

02.10.26**Empfehlungen**
der Ausschüsse

FSFJ - Fz - In - R

zu **Punkt ...** der 1069. Sitzung des Bundesrates am 16. Oktober 2026

Entschließung des Bundesrates "Flächendeckender Ausbau multiprofessioneller Kinderschutzstrukturen"**- Antrag der Länder Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, Hamburg -****A**Der **federführende Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (FSFJ)**
undder **Ausschuss für Innere Angelegenheiten (In)**

empfehlen dem Bundesrat, die Entschließung nach Maßgabe der folgenden Änderungen zu fassen:

In 1. Zu Nummer 3 Satz 2 – neu – bis Satz 4 – neu –

Nach Nummer 3 sind die folgenden Sätze einzufügen:

„Bei der Erarbeitung des Konzepts sind die in den Ländern bereits bestehenden kommunalen, regionalen und landesweiten Kooperations-, Beratungs-, Interventions- und Versorgungsstrukturen systematisch zu erfassen und einzubeziehen. Das Konzept soll bundesweit vergleichbare Qualitätsmaßstäbe gewährleisten, zugleich jedoch eine bedarfs- und strukturorientierte Umsetzung durch die Länder ermöglichen. Die nachhaltige, auskömmliche Finanzierung ist durch den Bund sicherzustellen.“

...

Begründung (nur gegenüber dem Plenum):

Die Entschlieung enthlt bislang keine ausdrckliche Verpflichtung, die in den Lndern bereits bestehenden kommunalen, regionalen und landesweiten Kinderschutz-, Kooperations- und Versorgungsstrukturen bei der Konzepterstellung systematisch zu bercksichtigen. Eine entsprechende Ergnzung ist erforderlich, um die etablierten Strukturen – in Nordrhein-Westfalen beispielsweise die Netzwerke Kinderschutz nach § 9 des Landeskinderschutzgesetzes NRW und die vorhandenen beziehungsweise geplanten Huser des Kinderschutzes – sachgerecht einzubeziehen.

Die Ergnzung stellt zugleich sicher, dass bundesweit vergleichbare Qualittsmastbe geschaffen werden, ohne erfolgreiche landesspezifische Anstze oder regional erforderliche Ausgestaltungen zu beeintrchtigen. Die Forderung nach einer verbindlichen, auskmmlichen und nachhaltigen Bundesfinanzierung ist ausdrcklich zu untersttzen.

FSFJ 2. Zu Nummer 3 Satz 2 – neu –, 3 – neu –

Nach Nummer 3 sind die folgenden Stze einzufgen:

„Dazu gehrt auch eine auskmmliche und nachhaltige Finanzierung der ambulanten medizinischen Leistungen von Kinderschutzambulanzen an Krankenhusern, die in Kooperation mit den Trgern der Jugendhilfe wichtige vernetzte Leistungen erbringen sollen. Die Bundesregierung wird aufgefordert, den § 118b SGB V so zu ndern, dass eine auskmmliche und nachhaltige Finanzierung der ambulanten medizinischen Leistungen von Kinderschutzambulanzen an dafr geeigneten Krankenhusern bundesweit ermglicht wird.“

Folgenderung:

Nach der Begrndung zu Nummer 3 Satz 4 sind die folgenden Stze einzufgen:

„Krankenhuser, die ambulante kindermedizinische Leistungen fr einen gelingenden Kinderschutz erbringen wollen, scheitern aktuell an den Zulassungsausschssen der rzte und Krankenkassen, weil die Auslegung des § 118b SGB V durch die Selbstverwaltung viel zu eng ist. Damit wird dieses wichtige Versorgungsangebot verhindert. Und das obwohl auch die niedergelassenen Kinderrzte einen solchen Bedarf der Versorgung durch geeignete Krankenhuser bejahen. Es soll bundesweit mglich sein, diese fr den Kinderschutz zentrale ambulante kindermedizinische Leistung an geeigneten Krankenhusern zu erbringen. Kinderschutz darf nicht an den

Sektorengrenzen des Gesundheitssystems und der Kinder- und Jugendhilfe scheitern.“

B

3. Der **Finanzausschuss** und
der **Rechtsausschuss**
empfehlen dem Bundesrat, die EntschlieÙung zu fassen.